

Sinais Clínicos de Apendicite Aguda

Resumo Executivo

A apendicite aguda é diagnosticada essencialmente pelo quadro clínico e pelo exame físico abdominal. Na suspeita de apendicite, procuramos sinais de irritação peritoneal localizados no quadrante inferior direito (QID). Destacam-se clássicos 10 sinais semiológicos: sensibilidade no ponto de McBurney, *Blumberg*, *Rovsing*, *Psoas*, *Obturator*, *Dunphy*, *Aaron*, *Lenander*, *Ten Horn* e *Summer*. Cada manobra revela um mecanismo fisiopatológico distinto: por exemplo, a palpação rápida seguida de alívio brusco (*Blumberg*) evidencia peritonite focal [62†L159-L163] [52†L229-L236]; a compressão do lado esquerdo (*Rovsing*) desloca gases e distende o ceco inflamado [4†L256-L264] [22†L151-L158]; o estiramento do músculo íliopsoas (*psoas*) ou do obturador causa dor quando o apêndice retrocecal/pélvico irrita essas estruturas [62†L162-L164] [65†L269-L272]. Em geral esses sinais têm baixa sensibilidade individual (muitos abaixo de 50%), mas alta especificidade (ex.: sinal de *Blumberg* sens ≈ 81%, esp ≈ 49%; obturador sens ≈ 8%, esp ≈ 94%) [52†L229-L236] [52†L270-L276]. Os sinais de *Dunphy* (dor intensificada ao tossir) e *Aaron* (dor referida epigástrica à palpação em McBurney) podem ser úteis, embora sejam inespecíficos. O *Lenander* avalia febre dissociada (temperatura retal > axilar em >1°C) [36†L116-L122], e *Ten Horn* e *Summer* exploram reflexos genitofemorais e hipersensibilidade cutânea local [65†L269-L276] [41†L1-L4]. Em conjunto, esses achados orientam a hipótese clínica: presença de ≥ 1 sinal positivo eleva muito a chance de apendicite, direcionando para confirmação por imagem (ultrassom/TC) e cirurgia [52†L229-L236] [50†L319-L323]. A tabela a seguir compara resumidamente cada sinal.

Sinal	Manobra (breve)	Local da dor/ hipersensibilidade	Mecanismo fisiopatológico	Sensibilidade/ Especificidade	Notas Práticas
Ponto de McBurney (tenderness)	Palpação profunda no ponto de McBurney (2/3 da linha umbigo-ESIA) [9†L235-L242] [50†L394-L402]	<i>Localizado</i> : QID (ponto de McBurney)	Inflamação parietal do apêndice causa dor focal na região.	(não quantificado)	Achado comum inicial. Confirma apenas sensibilidade local, mas não patognomônico.
Blumberg	Compressão gradual seguida de alívio brusco no QID [62†L159-L163] [52†L233-L236]	Dor intensa no QID após soltura súbita	Distensão rápida do peritônio irritado (peritonite local)	Sens. ~81%; Esp. ~49% [52†L229-L236]	Sinal clássico de peritonite. Falso-positivos em qualquer irritação peritoneal (diverticulite, colite, etc.).

Sinal	Manobra (breve)	Local da dor/ hipersensibilidade	Mecanismo fisiopatológico	Sensibilidade/ Especificidade	Notas Práticas
Rovsing	Palpar e comprimir a fossa ilíaca esquerda	Dor referida no QID	Pressão contralateral empurra gases antiperistálticos até o ceco inflamado 【22†L151-L158】 【54†L509-L512】	Baixa (variável) / Moderada	Sinal de <i>sensibilidade de rebote referida</i> . Indica irritação caecal/ apendicular. Sinal inespecífico; comuns falsos em outros abdômes agudos.
Psoas (Cope)	Paciente em decúbito lateral esquerdo; estender e abduzir passivamente a coxa direita 【62†L162-L164】	Dor no QID ao esticar o quadríceps direito	Inflamação retrocecal irrita o músculo ilíopsoas 【50†L294-L300】	Sens. ~13–42%; Esp. ~79–97% 【50†L294-L300】	Sugere apêndice retrocecal. Falso-positivos: abscesso psoas, colecistite (pós cirúrgica) ou irritação pélvica.
Obturator	Paciente supino; flexionar quadril e joelho direito 90° e girar internamente o quadril 【65†L269-L272】	Dor no QID durante rotação interna do quadril	Inflamação pélvica do apêndice irrita o músculo obturador interno 【52†L270-L276】	Sens. ~8%; Esp. ~94% 【52†L270-L276】	Indica apêndice em posição pélvica. Falso-positivo: abscesso pélvico, doença pélvica inflamatória (ovário/trompa).
Dunphy	Paciente sentado ou em pé; pedir para tossir (batida breve) ou bater calcanhar	Dor agravada no QID ao tossir	Vibração/transmissão ao peritônio inflamado, causando dor focal 【50†L319-L323】	Sens. ~95%; Esp. ~80% 【50†L319-L323】	Sinal simples e sensível para peritonite focal. Falsos: tosse forte pode causar dor em qualquer área sensível.

Sinal	Manobra (breve)	Local da dor/ hipersensibilidade	Mecanismo fisiopatológico	Sensibilidade/ Especificidade	Notas Práticas
Aaron	Pressão firme contínua sobre ponto de McBurney	Dor referida no epigástrio (ou região torácica) 【57†L116-L124】	Irradiação de dor viscerossomática via nervos do apêndice	Não há dados quantitativos	Clássico para apendicite crônica (histórico). Pouco utilizado no agudo; falsos: qualquer dolor abdominal irradiada.
Lenander	Medir temperatura retal e axilar consecutivamente	N/A (sinal não doloroso)	Febre interna (retal) > externa (axilar) indica inflamação pélvica/ abdominal 【36†L116-L122】	—	Simples, mas inespecífico. Elevação maior que 1°C sugere foco inflamatório profundo; falso-negativo em crianças/idosos ou uso de antipiréticos.
Ten Horn	Tração gentil do testículo direito para baixo	Dor abdominal referida ao QID	Tração irrita o nervo genitofemoral, refletindo quadro apendicular 【65†L272-L276】	—	Indicativo de apendicite retrocecal, comum em homens jovens. Falsos: torção testicular, orquite ou inflamação de cordão espermático.
Summer	Leve fricção cutânea ou toques repetidos no QID	Hipersensibilidade cutânea aumentada no QID 【65†L273-L276】 【41†L1-L4】	Cutis e peritônio sensibilizados pela inflamação (hiperalgesia)	—	Demonstra hiperestesia dermatômica típica do abdome agudo. Limitação: subjetivo (depende de relato) e presentes também em outras peritonites.

Para organizar o diagnóstico, pode-se usar um fluxograma (Mermaid) como o exemplo abaixo:

```
graph TD
    A[Suspeita de Apendicite Aguda] --> B[História clínica (dor periumbilical migratória, náuseas, etc.)]
    B --> C[Exame físico completo (palpação, percussão, manobras especiais)]
    C --> D{Presença de sinais clínicos nos manobras?}
    D -- Sim (>=1 sinal positivo) --> E[Alta suspeita clínica: solicitar imagem (US/TC) e considerar apendicectomia]
    D -- Não --> F[Avaliar diferenciais (esteatite, outras causas de dor abdominal) e observá-los]
    E --> G[Conduta cirúrgica ou tática de espera conforme confirmação de apendicite]
    F --> G
```

As referências utilizadas incluem manuais brasileiros e textos clínicos de semiologia e cirurgia [62†L159-L163] [52†L229-L236] [22†L151-L158] [50†L294-L300] [36†L116-L122] [65†L269-L276] , que confirmam definições, fisiopatologia e estatísticas principais de cada sinal. Em geral, os sinais semiológicos devem ser interpretados em conjunto; nenhum é definitivo isoladamente, mas vários positivos juntos reforçam fortemente o diagnóstico de apendicite aguda [52†L229-L236] [50†L319-L323] .
